

Eritema nodoso

Bibliografía 2021 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David
AEP 2020

Es una paniculitis (inflamación del tejido adiposo) septal que resulta de una reacción de hipersensibilidad frente a numerosos estímulos, que suele afectar al tejido celular subcutáneo de la región pretibial de las extremidades inferiores.

Prevalencia estimada de 1 a 5 casos/100 000 personas y, aunque puede aparecer a cualquier edad, es más frecuente entre los 18 y 34 años.

Patogénesis

El EN se produce por una reacción de hipersensibilidad en respuesta a numerosos antígenos, formándose una paniculitis neutrofílica con depósito de inmunocomplejos alrededor y dentro de los vasos sanguíneos de los septos del tejido celular subcutáneo, produciéndose la activación del complemento. El depósito de neutrófilos desencadena un daño oxidativo tisular y la formación de granulomas “de Miescher” (en fases precoces), con el tiempo se produce fibrosis y posible extensión de la inflamación a los adipocitos adyacentes

Etiología

- **Eritema nodoso primario o idiopático**

Aproximadamente, en el 40-50% de los casos, en los que no se puede identificar ninguna causa.

- **Eritema nodoso secundario**

Cuando hay relación con una enfermedad subyacente.

La causa conocida más frecuentemente implicada es la infecciosa. Destacan las infecciones respiratorias de vías altas por estreptococo β -hemolítico del grupo A (pasadas 2-3 semanas de la infección, cuando ya el frotis faríngeo suele ser negativo); seguidas de tuberculosis. Además, puede ser debido a Salmonella enteritidis y Campylobacter jejuni, infecciones víricas, fúngicas (tanto micosis superficiales como profundas) y parasitarias. Puede ser también el signo de una enfermedad reumática como lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, enfermedad de Behçet y otras vasculitis (principalmente púrpura de Schönlein-Henoch en la infancia).

Puede deberse a otras enfermedades autoinmunes de índole digestivo como enfermedad inflamatoria intestinal, hepatitis autoinmune, enfermedad celíaca y gastritis atrófica.

El EN puede relacionarse con enfermedades malignas (infrecuente, sobre todo relacionado con leucemias y linfomas)⁶, administración de determinados fármacos (principalmente antibióticos y anticonceptivos orales), embarazo (generalmente en segundo trimestre de gestación), vacunas (muy infrecuente), etc.

Clínica

El EN se manifiesta como placas o nódulos subcutáneos eritematosos, dolorosos e indurados, de 1 a 5 cm de diámetro, que suelen ser profundos (más palpables que visibles), simétricos y bilaterales, afectando sobre todo a regiones pretibiales, aunque pueden aparecer en otras localizaciones como zonas de extensión de muslos y brazos, incluso en tronco. Suele durar aproximadamente una semana y desaparecer en 2-6 semanas sin dejar cicatriz ni ulceración. Al inicio las lesiones presentan una coloración roja brillante y protruyen ligeramente sobre la piel, posteriormente se van aplanando y adquieren un tinte purpúrico y, finalmente, dejan una apariencia amarillo-verdosa residual hasta su resolución.

Pueden aparecer síntomas generales como fiebre, astenia, artralgias, mialgias, adenopatías, hepatoesplenomegalia y cualquier manifestación clínica relacionada con la enfermedad de base.

Diagnóstico y pruebas complementarias

El diagnóstico del EN es principalmente clínico. La aparición aguda de nódulos eritematosos bilaterales en la región pretibial de ambas extremidades inferiores es característica². La fiebre y el dolor articular pueden preceder a la erupción cutánea.

Estudios iniciales

- Hemograma
- VSG
- PCR
- Test rápido de estreptococo y/o frotis faringoamigdalares.
- Determinación de títulos de antiestreptolisina O (ASLO).
- Radiografía de tórax.
- PPD

Otras pruebas complementarias (valorarse de forma individualizada):

- Sedimento urinario
- Serologías víricas
- Coprocultivo, virológico y coproparasitológico
- Complemento y determinación de autoanticuerpos
- Niveles de enzima convertidora de angiotensina (ECA)
- Test de embarazo si hay sospecha en adolescentes
- Endoscopia si hay síntomas digestivos.

Evolución y pronóstico

En general, el pronóstico del EN es excelente. En la mayoría de los pacientes se resuelve espontáneamente en un plazo de 2-8 semanas sin secuelas⁶. En casos de EN severo, este puede tardar en resolverse más de 12 semanas.

Se pueden presentar recurrencias en hasta un tercio de los pacientes.

Tratamiento

El tratamiento del EN es principalmente sintomático. El reposo con elevación de extremidades inferiores asociado a la administración de AINES constituye el tratamiento de elección.

Los corticoides sistémicos constituyen la segunda línea de tratamiento y están indicados en casos severos y complicados, siendo rápidamente efectivos en el alivio del dolor y la resolución de las lesiones, con riesgo de recidivas al suprimirlos. Se suelen utilizar a dosis bajas de 1 mg/kg/día y durante periodos cortos de tiempo (7-10 días). Es importante descartar previamente infecciones latentes y administrar protección gástrica.